PSIQUIATRIA

Transtorno afetivo bipolar e personalidade | Resumo e PTS

Resumo de tutoria e plano terapêutico singular

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

17 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO · PSIQUIATRIA

Transtorno Afetivo Bipolar e Transtornos de Personalidade

BLOCO 1

Conceitos que organizam tudo

Duas lógicas diferentes: o transtorno afetivo bipolar é uma doença de episódios; o transtorno de personalidade é um padrão contínuo. *Essa frase resolve a maior parte do diferencial.*

O **episódio de humor** é a unidade diagnóstica do transtorno afetivo bipolar (TAB): um período delimitado, com início e fim identificáveis, em que o humor se desloca do habitual e *permanece* deslocado por um tempo mínimo definido, acompanhado de alteração da energia e da atividade dirigida a objetivos. Fora dos episódios o paciente retorna a uma linha de base reconhecível. O transtorno de personalidade é o oposto estrutural: um padrão persistente de cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulsos que se desvia das expectativas culturais, é **inflexível e difuso**, tem início na adolescência ou início da vida adulta e é estável ao longo do tempo. Não há intervalo livre porque não há episódio — há a pessoa.

O TAB atinge cerca de 1% da população na forma tipo I e algo em torno de 2% quando se considera o espectro completo. A latência entre o primeiro sintoma e o diagnóstico correto chega a **uma década**, por três razões práticas: o paciente procura ajuda na depressão e não na hipomania (que ele vive como boa fase ou como o "seu normal"), a hipomania não gera prejuízo suficiente para motivar consulta, e o informante colateral raramente é ouvido.

Fisiopatologia em uma cadeia

O modelo mais útil encadeia: **vulnerabilidade poligênica** (herdabilidade alta, em torno de 70–80%) que se expressa como instabilidade da sinalização intracelular neuronal e desregulação de ritmos circadianos → um **gatilho** (privação de sono, substância, antidepressivo, estresse) desestabiliza o sistema → desequilíbrio entre o controle pré-frontal e a reatividade límbica, com alteração de dopamina e de neurotransmissão excitatória → **episódio clínico** → cada episódio facilita o seguinte (fenômeno de *kindling*: gatilhos progressivamente menores bastam) e contribui para déficit cognitivo cumulativo. Daí a consequência terapêutica central: **prevenir episódios não é comodidade, é neuroproteção**.

> **MACETE**
> O ponto de maior alavancagem clínica na cadeia acima é o **sono**. Redução da necessidade de sono é sintoma *e* gatilho: proteger o sono interrompe o ciclo antes que ele se feche. É a orientação não farmacológica com melhor relação custo-benefício em psicoeducação.

BLOCO 2

Diagnóstico do transtorno afetivo bipolar

Os três episódios

Os sintomas acessórios da mania e da hipomania são sete e exigem-se **três** (ou quatro, se o humor for apenas irritável): autoestima inflada ou grandiosidade; **redução da necessidade de sono** (dorme pouco e não sente falta — distinto de insônia); fala acelerada ou pressão por falar; fuga de ideias; distratibilidade; aumento da atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora; envolvimento excessivo em atividades com alto potencial de consequências dolorosas (gastos, sexo, negócios).

No **episódio depressivo maior** exigem-se **cinco ou mais** sintomas em duas semanas, sendo ao menos um deles humor deprimido ou anedonia. Os sete acessórios são: alteração de apetite ou peso (perda ou ganho significativos); insônia ou hipersonia; agitação ou retardo psicomotor observável por outros; fadiga ou perda de energia; sentimento de inutilidade ou culpa excessiva e inadequada; redução da capacidade de concentração ou indecisão; e **pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, plano ou tentativa**.

Episódio	Duração mínima	Núcleo	Repercussão
Mania	≥ 1 semana (ou qualquer duração se houver internação)	Humor elevado, expansivo ou irritável **+ aumento de energia/atividade**, na maior parte do dia, quase todos os dias	Prejuízo acentuado, necessidade de internação **ou** sintomas psicóticos
Hipomania	≥ 4 dias consecutivos	Mesmos sintomas, mesma exigência de aumento de energia	Mudança **observável por outros**, sem prejuízo acentuado, sem internação e **sem psicose**
Depressão maior	≥ 2 semanas	Humor deprimido *ou* anedonia + ≥ 4 dos sete acessórios — **5 sintomas no total**	Sofrimento ou prejuízo funcional

Tabela 1 — Os três episódios do espectro bipolar. Os sintomas de mania e hipomania são os mesmos; o que difere é gravidade, duração e presença de psicose ou internação.

Como os tipos se organizam

A Figura 1 contrasta os três padrões na mesma escala de tempo.

- **TAB tipo I** — basta **um** episódio maníaco na vida. Depressão não é exigida para o diagnóstico, embora ocorra na quase totalidade dos casos.
- **TAB tipo II** — exige **ao menos um episódio hipomaníaco e ao menos um depressivo maior**, e **nunca** um episódio maníaco. Um único episódio maníaco reclassifica definitivamente para tipo I.
- **Ciclotimia** — ao menos dois anos (um ano em crianças e adolescentes) com numerosos períodos de sintomas hipomaníacos e depressivos que **nunca** preenchem critérios completos, com sintomas presentes em ao menos metade do tempo e sem intervalo livre maior que dois meses.

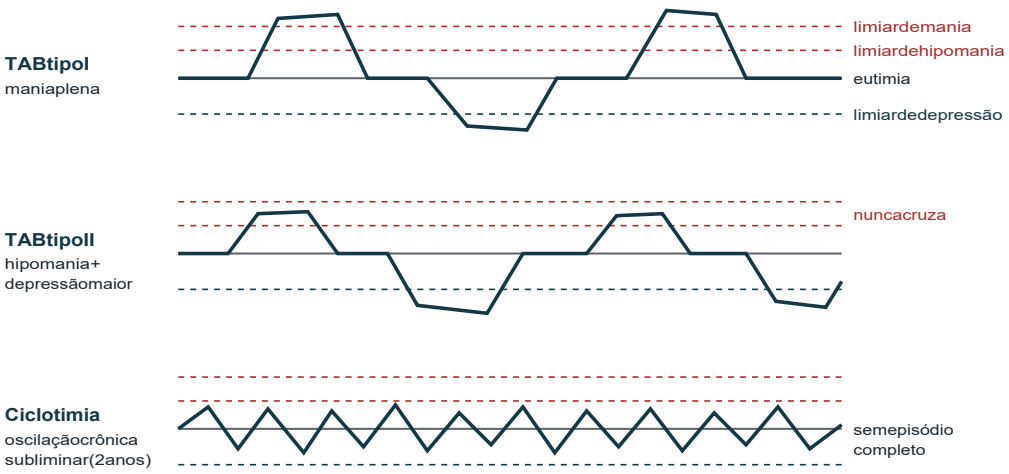


Figura 1 — Padrão temporal dos três quadros do espectro bipolar. O eixo horizontal é o tempo em meses a anos. O que distingue os tipos não é a intensidade instantânea do sofrimento, mas até onde a curva sobe e por quanto tempo permanece acima do limiar. Compare com a Figura 3: lá, a mesma escala de tempo mostra o padrão do transtorno de personalidade borderline.

Especificadores que mudam a conduta

- **Com características mistas** — sintomas do polo oposto durante o episódio. Aumenta risco de suicídio, piora resposta a antidepressivo e favorece o uso de valproato ou antipsicótico.
- **Ciclagem rápida** — ≥ 4 episódios em 12 meses. Investigar hipotireoidismo, uso de antidepressivo e substâncias; o ácido valproico costuma ser preferido ao lítio.
- **Com sintomas psicóticos** — presente apenas na mania ou na depressão, nunca na hipomania (por definição).
- **Com ansiedade, com padrão sazonal, com início no periparto** — o periparto é o período de maior risco de recaída de toda a doença.

Quando suspeitar de bipolaridade em um paciente deprimido

Todo quadro depressivo exige rastreio ativo de episódio prévio de elevação do humor. As pistas mais úteis: **início precoce** (antes dos 25 anos); episódios depressivos recorrentes e curtos; **história familiar de TAB** em parente de primeiro grau; depressão com sintomas atípicos (hipersonia, hiperfagia, lentificação); sintomas psicóticos; depressão pós-parto; **virada ou agitação após início de antidepressivo**; e falha de múltiplos antidepressivos. A pergunta de triagem deve ser comportamental, não afetiva: pacientes negam "humor alto" mas confirmam noites dormindo pouco sem sentir cansaço, com energia aumentada, notadas por outras pessoas.

> **ATENÇÃO**
> Não há exame que confirme TAB — o diagnóstico é clínico. Os exames servem para afastar mania secundária e para basear o tratamento: função tireoidiana, função renal, hemograma, glicemia, perfil lipídico, rastreio toxicológico e, quando houver sintoma neurológico focal, primeiro episódio tardio ou apresentação atípica, neuroimagem. Diferenciais obrigatórios: uso de substâncias, corticoide, hipertireoidismo, lesão frontal, demência frontotemporal, esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo, TDAH e transtornos de personalidade.

BLOCO 3

Tratamento do transtorno afetivo bipolar

Trata-se o episódio para obter remissão e trata-se a doença para evitar o próximo. A segunda lógica é a que determina o prognóstico.

Antes de qualquer prescrição diante de mania: avaliar risco de agressividade, risco de suicídio, grau de *insight* e capacidade de adesão; afastar mania secundária; **suspender antidepressivos** e demais precipitantes. Encaminhar à emergência psiquiátrica os pacientes com risco agudo de suicídio, agitação psicomotora, auto ou heteroagressividade, risco de exposição moral ou sintomas psicóticos.

Episódio maníaco

Tempo de tratamento da fase aguda de **8 a 24 semanas**; a conduta mais eficaz é a associação de estabilizador do humor com antipsicótico, superior à monoterapia. Avaliar resposta em **até duas semanas** em dose adequada antes de trocar, e trocar apenas o componente que falhou.

Nível	Estabilizador	Antipsicótico	Observação
Nível 1	Carbonato de lítio	Risperidona	Combinação de escolha no SUS
Nível 2	Ácido valproico	Olanzapina	Valproico é alternativa em ciclagem rápida e episódios mistos

Nível	Estabilizador	Antipsicótico	Observação
Nível 3	Carbamazepina	Haloperidol ou quetiapina	Carbamazepina reduz o nível sérico da maioria dos antipsicóticos
Nível 4	Clozapina		Somente após falha de **duas** combinações

Tabela 2 — Níveis de recomendação para o episódio maníaco no protocolo brasileiro. As diretrizes canadenses são mais amplas e incluem em primeira linha lítio, valproato, quetiapina, aripiprazol, risperidona, asenapina, cariprazina e paliperidona; a di*ferença é de escopo (fármacos incorporados ao SUS), não de qualidade de evidência.*

Para agitação, os antipsicóticos são os mais indicados, com **preferência pela via oral** sempre que possível — há evidência de eficácia comparável à via intramuscular.

Depressão bipolar

Preferencialmente **monoterapia**, com avaliação de resposta em **4 a 6 semanas** (intervalo maior que o da mania). Ordem do protocolo brasileiro: nível 1 carbonato de lítio; nível 2 quetiapina; nível 3 lamotrigina; nível 4 associações com fluoxetina (com olanzapina, lítio ou ácido valproico), reservadas à refratariedade ou intolerância.

> **PEGADINHA DE PROVA**
> Antidepressivo **em monoterapia é claramente contraindicado** na depressão bipolar. Quando indicado, o protocolo brasileiro recomenda fluoxetina e sempre **em combinação**. O risco não é apenas a virada maníaca: é também indução de ciclagem rápida e piora de estados mistos.

Manutenção

- **Mantenha o que funcionou** no episódio agudo, ajustando a dose à tolerabilidade de longo prazo.
- **Carbonato de lítio é a primeira escolha** na manutenção. Também têm eficácia comprovada: ácido valproico, lamotrigina, olanzapina, quetiapina, risperidona, carbamazepina e clozapina.
- **Lamotrigina previne apenas recaídas depressivas** — nunca isolada em quem tem mania; deve acompanhar agente com eficácia antimaníaca.
- **Antidepressivo:** salvo recorrências depressivas numerosas, reduzir após **6 a 8 semanas de remissão** e suspender sempre que possível.
- **Psicoeducação, higiene do sono e adesão** não são acessórios: são o que sustenta a farmacoterapia. A eletroconvulsoterapia permanece indicada em mania ou depressão graves refratárias, catatonia, recusa alimentar e gestação.

Situações especiais e contexto brasileiro

- **Gestação** — o ácido valproico é o de maior risco teratogênico (defeitos de tubo neural, prejuízo cognitivo) e deve ser evitado em mulheres em idade fértil sem contracepção eficaz; o lítio associa-se a risco de anomalia cardíaca (Ebstein), menor do que se supunha historicamente, e a decisão é sempre de balanço risco–benefício com a paciente. O periparto é o período de maior risco de recaída.
- **Idosos e nefropatas** — doses menores de lítio, litemia mais frequente, atenção redobrada a diuréticos e anti-inflamatórios.
- **SUS** — o tratamento se organiza na Rede de Atenção Psicossocial, com o CAPS como ponto de referência para casos moderados a graves; a dispensação de lítio, valproico, carbamazepina e antipsicóticos segue o componente do protocolo, exigindo Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

BLOCO 4

Lítio: prescrição, monitorização e toxicidade crônica

O lítio é um íon, não uma molécula desenhada para um receptor. Quase tudo o que importa clinicamente decorre disso.

Quatro fatos encadeados explicam a toxicidade: é **rápida e completamente absorvido** por via oral, com pico em cerca de uma a uma hora e meia; **não é metabolizado** e não se liga a proteínas; é eliminado **quase inteiramente pelos rins**; e no túbulo proximal é **reabsorvido junto com o sódio**. Logo, toda situação em que o rim precisa poupar sódio — desidratação, dieta hipossódica, diurético, queda de perfusão — faz poupar lítio na mesma proporção. Some-se o **índice terapêutico estreito**: faixa terapêutica de 0,6 a 1,2 mEq/L e risco de toxicidade que cresce muito acima de **1,5 mEq/L**.

O carbonato de lítio é o fármaco mais bem validado no TAB e o **único** que demonstra redução de suicidalidade e de mortalidade por todas as causas em transtornos do humor — a razão de ocupar a primeira linha nas três fases.

Carbonato de lítio

ESTABILIZADOR DO HUMOR — ÍON MONOVALENTE QUE MODULA A SINALIZAÇÃO INTRACELULAR E A EXCITABILIDADE NEURONAL

APRESENTAÇÃO

Comprimidos de **300 mg** — única apresentação da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

DOSE E VIA

Via oral, dose única à noite. Iniciar com 300 mg/dia, incremento de 300 mg a cada 2 dias até 900 mg/dia, quando se dosa o nível sérico. Faixa de 300 a 1.800 mg/dia; máximo de 1.800 mg/dia.

ALVO SÉRICO E COLETA

Litemia de **0,6 a 1,2 mEq/L**, colhida após **5 a 7 dias** de dose estável e **12 horas** após a última tomada. Fora dessa janela o resultado é ininterpretável.

ANTES DE INICIAR

Hormônio tireoestimulante, creatinina e ureia; mais peso, altura, circunferências, três medidas de pressão arterial, perfil lipídico, glicemia de jejum e hemograma.

MONITORIZAÇÃO

Trimestral: creatinina e ureia. **Semestral:** hormônio tireoestimulante, cálcio sérico e litemia.

CONTRAINDICAÇÕES

Absolutas: insuficiência renal grave, bradicardia sinusal, arritmias ventriculares graves, insuficiência cardíaca congestiva, hipersensibilidade. Relativas: hipotireoidismo e gravidez.

EFEITOS ADVERSOS

Náuseas, vômitos, dor epigástrica, boca seca, **gosto metálico**, diarreia, ganho de peso, **tremor fino**, cansaço, cefaleia, hipotireoidismo, exacerbação de psoríase e acne.

MACETE

A monitorização crônica persegue exatamente os três órgãos que o lítio agride: **rim** (creatinina e ureia), **tireoide** (hormônio tireoestimulante) e **paratireoide** (cálcio) — mais a litemia. Lembrou dos órgãos, lembrou dos exames.

Toxicidade crônica (distinta da intoxicação aguda): no rim, **diabetes insípido nefrogênico** — poliúria e polidipsia por incapacidade de concentrar a urina, criando a armadilha de desidratar e reter mais lítio; além de declínio lento da filtração glomerular. Na tireoide, **hipotireoidismo** frequente, em geral subclínico, que se trata com levotiroxina *sem* suspender o lítio. Na paratireoide, hiperparatireoidismo com **hipercalcemia**. E tremor fino dose-dependente, psoríase e acne.

PEGADINHA DE PROVA

Tremor fino é efeito adverso esperado e tolerável. **Tremor grosseiro**, ataxia e fasciculações são sinais de *intoxicação*. O caso típico: paciente em lítio crônico que iniciou hidroclorotiazida há duas semanas e agora tem tremor grosso e marcha instável — isso é intoxicação até prova em contrário; dose-se a litemia e suspenda o lítio, não se aumente a dose.

BLOCO 5

Intoxicação por lítio

A pergunta que organiza o atendimento não é "qual a litemia?", e sim "que tipo de intoxicação é esta?".

Os três padrões

- **Aguda** — ingestão maciça em quem *não* usa lítio. Tecido ainda não saturado; predominam sintomas **gastrointestinais** precoces. Litemia alta com pouca neurotoxicidade.
- **Aguda sobre crônica** — sobrecarga em paciente já em uso; padrão mais frequente nas tentativas de suicídio.
- **Crônica** — acúmulo em dose habitual, quase sempre com precipitante identificável. O lítio já está intracelular: predominam sintomas **neurológicos** e a litemia pode estar apenas discretamente elevada em paciente encefalopático. É o padrão mais perigoso e o mais subdiagnosticado.

RACIOCÍNIO CLÍNICO

A dissociação entre litemia e gravidade na forma crônica tem explicação mecanicista: o que produz neurotoxicidade é o lítio **intracelular no sistema nervoso central**, e a litemia mede o lítio **plasmático**. Na intoxicação aguda os compartimentos ainda não equilibraram e o plasma *superestima* o cérebro; na crônica já equilibraram e o plasma *subestima*. Por isso a decisão na intoxicação crônica é guiada pelo exame neurológico, não pelo número.

Precipitantes e quadro clínico

Diuréticos (sobretudo tiazídicos), inibidores da enzima conversora da angiotensina e antagonistas do receptor de angiotensina, anti-inflamatórios não esteroidais e qualquer condição que altere a função renal elevam a litemia e devem ser evitados. Na anamnese, procure ativamente: medicamento novo, **diarreia ou febre recentes, calor, redução de ingesta hídrica e dieta hipossódica**.

Sintomas: perda de equilíbrio, diarreia profusa, vômitos, anorexia, fraqueza, ataxia, visão borrada, zumbido, poliúria, **tremor grosseiro**, contrações musculares, irritabilidade e agitação; nos casos graves, sonolência, psicose, desorientação, convulsões, coma e insuficiência renal. Litemia acima de **3,5 mEq/L** é potencialmente fatal.

Gravidade	Faixa de litemia	Achados predominantes
Leve	1,5 – 2,0 mEq/L	Náuseas, vômitos, diarreia, tremor grosseiro, fraqueza, letargia leve
Moderada	2,0 – 2,5 mEq/L	Confusão, disartria, ataxia, nistagmo, fasciculações, hipertonia, mioclonias
Grave	> 2,5 mEq/L	Convulsões, rebaixamento de consciência, coma, arritmias, colapso circulatório, insuficiência renal

*Tabela 3 — Graduação tradicional da intoxicação por lítio. **Ressalva:** as faixas descrevem bem a forma aguda; na crônica a correlação entre litemia e gravidade é fraca e a classificação é clínica.*

Conduta em quatro tempos

A sequência completa, com os pontos de decisão, está na Figura 2.

1. **Medidas imediatas** — suspender o lítio *e* todo fármaco que reduza sua depuração (diurético, anti-inflamatório, inibidor da enzima conversora, antagonista de receptor de angiotensina). Avaliar via aérea, ventilação, circulação e nível de consciência; acesso venoso, monitorização cardíaca e glicemia capilar.
2. **Avaliação dirigida** — litemia imediata e **repetida a cada 2 a 4 horas** até queda consistente (dosagem isolada é insuficiente: a absorção pode estar em curso). Junto: sódio, potássio, cálcio, creatinina, ureia, gasometria, eletrocardiograma e hormônio tireoestimulante. Se ingestão intencional, rastrear co-ingestão.
3. **Reposição volêmica** — pilar do tratamento: **soro fisiológico a 0,9%**. Corrigida a depleção de sódio e a hipoperfusão, o túbulo proximal deixa de poupar sódio e volta a excretar lítio. **Não** se usa diurético para "forçar diurese" — o tiazídico faz o oposto do desejado.
4. **Decisão sobre tratamento extracorpóreo** — o único passo que é decisão, e não rotina.

> **ATENÇÃO**
> **Carvão ativado não adsorve lítio.** Só faz sentido se houver co-ingestão de substância adsorvível. Na ingestão aguda maciça de formulação de liberação prolongada, considerar irrigação intestinal total com polietilenoglicol.

Diálise: critérios do EXTRIP

O lítio é candidato quase ideal à diálise — peso molecular baixíssimo, sem ligação proteica, volume de distribuição pequeno. O grupo EXTRIP concluiu que é dialisável com nível de evidência A e sistematizou as indicações:

Força	Situação
Recomendado	Intoxicação grave por lítio
Recomendado	Função renal comprometida *e* litemia > 4,0 mEq/L
Recomendado	Rebaixamento de consciência, convulsões ou arritmias ameaçadoras à vida — **independentemente da litemia**
Sugerido	Litemia > 5,0 mEq/L · confusão significativa · tempo esperado para litemia < 1,0 mEq/L superior a 36 horas
Como conduzir	Hemodiálise preferencial; terapia de substituição renal contínua é alternativa aceitável. Manter até melhora clínica evidente ou litemia < 1,0 mEq/L; sem dosagem disponível, no mínimo 6 horas

Tabela 4 — Recomendações do EXTRIP. Todas com grau de evidência D (muito baixa): consenso sobre literatura majoritariamente observacional.

> **PEGADINHA DE PROVA**
> A indicação mais cobrada é a que **não depende do número**: rebaixamento de consciência, convulsão ou arritmia ameaçadora à vida indicam diálise *independentemente da litemia*. Litemia de 2,2 mEq/L em coma tem indicação; 3,0 mEq/L assintomático com função renal normal, não necessariamente.

Vale conhecer a crítica: em 361 pacientes com intoxicação crônica ou aguda sobre crônica, a aplicação estrita do EXTRIP teria indicado diálise em **58%** dos casos, enquanto apenas 2,5% foram dialisados, sem excesso correspondente de desfechos ruins. Os autores propõem exigir *simultaneamente* um critério de concentração e um critério clínico. Em prova, responda pelo EXTRIP; na enfermaria, saiba que a decisão é mais individualizada.

Depois da fase aguda restam duas tarefas: **corrigir o precipitante** (trocar o diurético, suspender o anti-inflamatório, orientar hidratação e sal) — reintroduzir sem isso é repetir o episódio — e reavaliar a indicação do próprio lítio, reintroduzindo só com volemia e função renal normalizadas, em dose reduzida e com litemia precoce. Conheça ainda a **síndrome de neurotoxicidade persistente induzida por lítio**: sequelas cerebelares (ataxia, disartria, nistagmo) e cognitivas por mais de dois meses após a normalização da litemia, sobretudo após intoxicação crônica grave com encefalopatia — o argumento mais forte contra a conduta expectante no paciente crônico com quadro neurológico franco.

BLOCO 5 · FLUXOGRAMA

Conduta na intoxicação por lítio

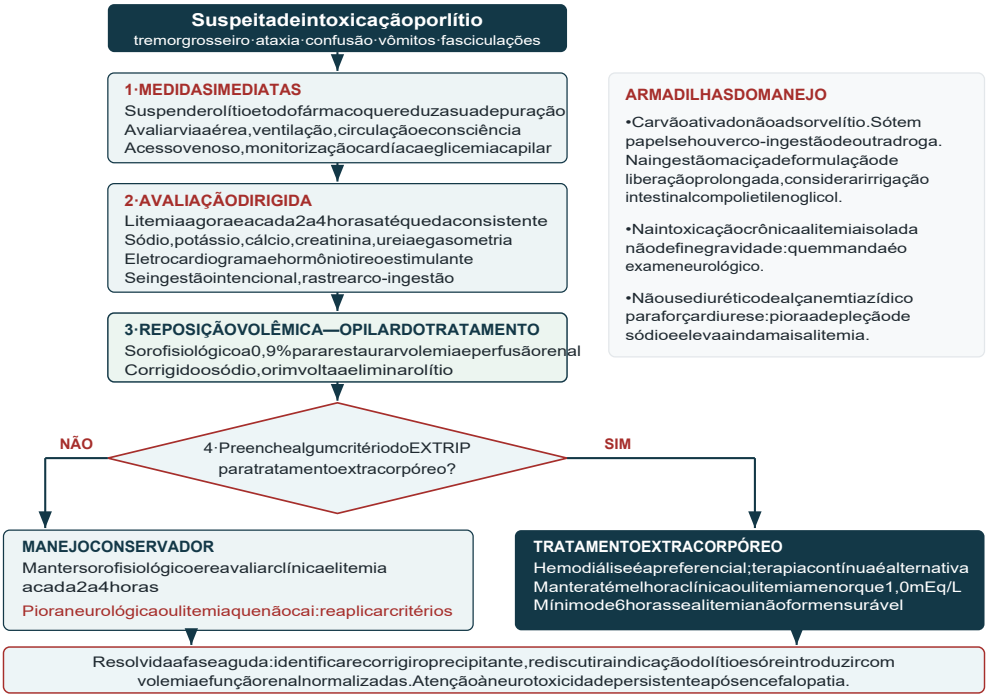


Figura 2 — Conduta sequencial na intoxicação por lítio. Os três primeiros passos são obrigatórios em todos os casos; apenas o quarto é uma decisão. A reposição volêmica precede e não substitui a avaliação de diálise: mesmo quem vai dialisar recebe soro fisiológico enquanto o acesso é providenciado. Critérios do EXTRIP na Tabela 4.

BLOCO 6

Transtornos de personalidade

O diagnóstico não se faz pelo sintoma do dia: faz-se pelo padrão que atravessa a biografia.

Os critérios gerais exigem um padrão persistente que se desvia acentuadamente das expectativas culturais, manifesto em **ao menos duas** de quatro áreas — cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulsos —, que seja **inflexível e difuso** em situações pessoais e sociais, cause sofrimento ou prejuízo, seja **estável e de longa duração com início na adolescência ou início da vida adulta**, e não seja mais bem explicado por outro transtorno mental, substância ou condição médica.

Grupo	Impressão dominante	Transtornos e traço nuclear
A	Estranheza — excêntricos e desconfiados	**Paranoide** (desconfiança pervasiva; lê intenções como malévolas) · **Esquizoide** (desinteresse por vínculos, restrição afetiva) · **Esquizotípica** (excentricidade, pensamento mágico, distorção perceptiva)
B	Intensidade — dramáticos e instáveis	**Antissocial** (violação dos direitos alheios; conduta já antes dos 15 anos) · **Borderline** (instabilidade de afeto, identidade e relações; impulsividade) · **Histriônica** (busca de atenção, emoção intensa porém superficial) · **Narcisista** (grandiosidade, necessidade de admiração, falta de empatia)
C	Medo — ansiosos e temerosos	**Evitativa** (inibição social por medo de crítica e rejeição) · **Dependente** (necessidade excessiva de cuidado, medo de separação) · **Obsessivo-compulsiva** (perfeccionismo e rigidez, controle à custa da eficiência)

Tabela 5 — Os dez transtornos de personalidade do DSM-5-TR. Os grupos organizam a memória pela impressão que o paciente causa ao examinador.

> **MACETE**
> Três pares que a prova adora confundir. Esquizoide não quer companhia; evitativa quer e tem medo.Esquizotípica tem estranheza do pensamento; paranoide tem desconfiança do outro.Personalidade obsessivo-compulsiva é rigidez de caráter egossintônica; o transtorno obsessivo-compulsivo tem obsessões e compulsões egodistônicas — a personalidade não é TOC, e o TOC não é obsessão nem ritual de personalidade.

A virada dimensional da CID-11

A CID-11 abandonou quase inteiramente as categorias. O diagnóstico passou a ter três etapas: (1) gravidade, obrigatória — leve, moderada ou grave, além de dificuldade de personalidade abaixo do limiar, refletindo o grau de disfunção do *self* e do funcionamento interpessoal e os riscos associados; (2) domínios de traço, opcionais — afetividade negativa, distanciamento, dissocialidade, desinibição e anancasmo (rigidez e perfeccionismo); **(3) padrão borderline**, único qualificador categórico remanescente, acrescentável quando o quadro corresponde à descrição clássica. A justificativa é clínica: o sistema categórico produzia subdiagnóstico, baixa estabilidade e enorme sobreposição — a maioria preenchia critérios para vários transtornos ao mesmo tempo. A gravidade é o componente principal; os traços descrevem, mas não definem.

> **RACIOCÍNIO CLÍNICO**
> Na prática, quatro perguntas identificam o padrão: **(1)** "Isso é assim desde quando?" — o padrão precisa vir da adolescência ou do início da vida adulta, não ter começado há seis meses. **(2)** "Acontece só com uma pessoa ou em todos os contextos?" — o transtorno é difuso. **(3)** "Como terminam suas relações e seus empregos?" — a repetição do mesmo desfecho é o achado. **(4)** "Como você fica quando não está em crise?" — a linha de base revela o traço. Some-se sempre um informante colateral e a exclusão de episódio de humor ativo, substância e condição médica.

BLOCO 7

Personalidade borderline em detalhe

Exige padrão difuso de **instabilidade das relações, da autoimagem e dos afetos, com impulsividade acentuada**, iniciado no início da vida adulta e presente em vários contextos, com **cinco ou mais** dos nove critérios: (1) esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado; (2) relações instáveis e intensas, alternando idealização e desvalorização; (3) perturbação da identidade; (4) impulsividade em pelo menos duas áreas autodestrutivas; (5) comportamento, gestos ou ameaças suicidas recorrentes ou automutilação; (6) **instabilidade afetiva por acentuada reatividade do humor, durando algumas horas e raramente mais de alguns dias**; (7) sentimentos crônicos de vazio; (8) raiva intensa e inapropriada; (9) ideação paranoide transitória ou sintomas dissociativos graves ligados ao estresse.

> **PEGADINHA DE PROVA**
> O critério 6 traz, dentro do próprio texto diagnóstico, a informação que resolve o diferencial com o TAB: a instabilidade afetiva do borderline dura **horas, raramente mais do que poucos dias**. Compare com as exigências de **quatro dias** para hipomania e **uma semana** para mania. A duração está escrita nos critérios de ambos.

Por que acontece. O modelo biossocial combina **vulnerabilidade emocional constitucional** (limiar mais baixo, intensidade maior, retorno mais lento à linha de base) com um **ambiente invalidante** no desenvolvimento, em que a emoção foi ignorada, punida ou tratada como exagero. A criança aprende que emoções comuns não obtêm resposta, passa a expressá-las de forma cada vez mais intensa, não desenvolve estratégias internas de regulação e chega à vida adulta sem ferramentas para tolerar afeto intenso. Autolesão, impulsividade e ameaças suicidas passam a funcionar como **regulação emocional de emergência**: aliviam a tensão no curtíssimo prazo e, por isso, se reforçam. Consequência terapêutica direta: é preciso **ensinar regulação**, não apenas suprimir o comportamento.

Curso. Mais favorável do que a fama sugere: os sintomas comportamentais — autolesão, tentativas, impulsividade — tendem a remitir substancialmente ao longo dos anos, sobretudo com tratamento; os estruturais — vazio crônico, dificuldade em sustentar relações e trabalho — persistem mais, e a recuperação funcional é mais lenta que a remissão sintomática. O risco de suicídio é real e persistente, amplificado por depressão e uso de substâncias comórbidos.

Tratamento

Psicoterapia é o tratamento, não o complemento. Revisão Cochrane com 75 ensaios randomizados e 4.507 participantes mostrou redução da gravidade dos sintomas em comparação ao tratamento usual, com diferença média padronizada de −0,52 (IC 95%: −0,70 a −0,33; 22 ensaios, 1.244 participantes; evidência de qualidade moderada). Predominam a **terapia comportamental dialética** — a mais eficaz na redução da gravidade, da autolesão e na melhora do funcionamento psicossocial — e a **terapia baseada em mentalização**, superior ao tratamento usual em autolesão e suicidalidade, com a ressalva de que a certeza das comparações diretas é baixa.

Farmacoterapia: não há medicamento com indicação aprovada para o transtorno em si. A orientação britânica é explícita: não usar fármaco especificamente para o transtorno nem para os sintomas isolados a ele associados; sedativo de curto prazo pode ser considerado na crise por não mais que uma semana, e antipsicóticos não devem ser usados no médio ou longo prazo. O que legitima prescrever é a **comorbidade** — depressão maior, ansiedade, uso de substâncias ou TAB coexistente.

CONDUTA PRÁTICA

Na crise com autolesão ou ideação suicida: **valide a emoção sem validar o comportamento**; avalie o risco de forma explícita; construa *com* o paciente um **plano de crise escrito**, com passos concretos e contatos; reduza o acesso a meios; e evite tanto a internação reflexa quanto a alta apressada. Internações prolongadas e não estruturadas tendem a reforçar o comportamento — mas risco agudo elevado continua sendo indicação de proteção.

BLOCO 8

Diferencial: bipolaridade *versus* instabilidade emocional

Os dois quadros compartilham instabilidade do humor, impulsividade e suicidalidade. O que os separa não é a lista de sintomas — é a arquitetura temporal em que eles aparecem.

A sobreposição é genuína, e se agrava no TAB tipo II, porque a hipomania é menos intensa e não psicótica, o que dificulta distingui-la das tempestades afetivas do borderline. Estima-se que, embora na maioria dos pacientes a diferenciação seja factível, em cerca de **20%** dos casos as condições se confundem de forma clinicamente significativa. Há ainda um complicador metodológico: a instabilidade afetiva, embora mais esperada no borderline, também é descrita em pacientes com TAB tipo II mesmo em eutimia — o sintoma isolado não discrimina; o que discrimina é o padrão.

O eixo do tempo. No TAB o humor muda em **blocos**: sobe, permanece elevado por dias a semanas, desce, e entre os blocos existe uma linha de base reconhecível à qual o paciente retorna. No borderline o humor muda em **picos**: sobe e desce em horas, várias vezes ao dia, quase sempre **acoplado a um evento interpessoal**, e a linha de base a que retorna já é ela própria disfórica e vazia. A Figura 3 põe os dois padrões na mesma escala.

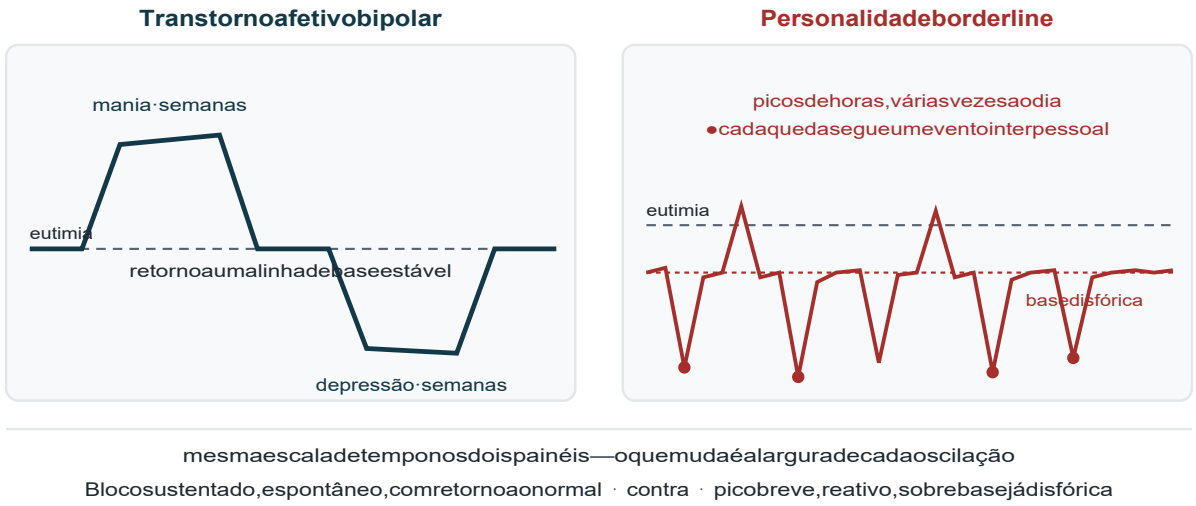


Figura 3 — A mesma escala de tempo, dois padrões diferentes. No painel esquerdo, a curva permanece acima ou abaixo do limiar por semanas e depois retorna a uma eutimia verdadeira. No painel direito, cada oscilação dura horas, é deflagrada por um evento interpessoal (pontos âmbar) e retorna a uma linha de base que já está abaixo da eutimia. Compare com a Figura 1.

Eixo	Transtorno afetivo bipolar	Personalidade borderline
Duração da oscilação	Dias a semanas (≥ 4 dias na hipomania, ≥ 1 semana na mania)	Horas, raramente mais que poucos dias
Gatilho	Frequentemente espontâneo; pode ser precipitado por perda de sono ou substância	Quase sempre interpessoal: rejeição, crítica, separação, abandono percebido
Linha de base	Eutimia identificável entre episódios	Disforia crônica e vazio; não há eutimia plena

Eixo	Transtorno afetivo bipolar	Personalidade borderline
Direção do afeto	Euforia, expansividade e grandiosidade genuínas na mania	Raiva, vazio, ansiedade e desespero; euforia sustentada é rara
Sono	**Redução da necessidade** de sono com energia preservada	Insônia por angústia, com cansaço no dia seguinte
Identidade	Estável entre episódios	Perturbação persistente da autoimagem e do senso de si
Relações	Prejudicadas *pelos* episódios	Instáveis o tempo todo, com idealização e desvalorização
Autolesão	Menos característica; risco concentrado em episódios e estados mistos	Recorrente, com função de alívio da tensão
História familiar	Transtorno bipolar em parentes de primeiro grau	Trauma, negligência e ambiente invalidante no desenvolvimento
Primeira linha	Estabilizador do humor; lítio	Psicoterapia estruturada; medicação só para comorbidade

Tabela 6 — Eixos de diferenciação. Nenhum item isolado fecha o diagnóstico; a convergência de vários, sim. São mais discriminativos *história familiar, antecedentes do desenvolvimento, curso e fenomenologia dos estados de humor; são **menos** discriminativos impulsividade, perfis neuropsicológicos, sexo, comorbidades e resposta ao tratamento.*

RACIOCÍNIO CLÍNICO

Três perguntas resolvem a maior parte dos casos ambíguos, e todas são sobre tempo e contexto, não sobre intensidade: **(1)** "Quanto tempo esse estado dura — horas ou dias?" **(2)** "O que estava acontecendo na sua vida quando começou?" **(3)** "Entre esses períodos, como você fica — normal ou já meio vazio?" Quem responde "horas", "briguei com meu namorado" e "nunca fico bem de verdade" descreve borderline. Quem responde "umas duas semanas", "do nada" e "eu volto ao normal" descreve TAB.

Marcadores biológicos — genética, ritmos circadianos, neuroimagem estrutural e funcional — mostram diferenças indicativas, mas ainda **insuficientes para orientar o diagnóstico individual**.

O erro custa caro nos dois sentidos. Diagnosticar TAB em quem tem borderline leva a anos de estabilizadores e antipsicóticos sem alvo — ganho de peso, síndrome metabólica, riscos do lítio — enquanto o tratamento que funcionaria não é oferecido. Diagnosticar borderline em quem tem TAB retarda o estabilizador, expõe a antidepressivo isolado e perde a chance de prevenir recorrências em uma doença de deterioração cumulativa.

PEGADINHA DE PROVA

As duas condições **podem coexistir**, e a comorbidade não é rara. O caso com episódios maníacos bem documentados e padrão crônico de instabilidade interpessoal desde a adolescência não pede que você escolha um: pede que reconheça os dois. Trata-se o TAB farmacologicamente e o padrão de personalidade com psicoterapia — as condutas se somam.

BLOCO 9

Revisão em 30 segundos

Transtorno afetivo bipolar

Mania = ≥ 1 semana (ou internação) + prejuízo acentuado ou psicose. Hipomania = ≥ 4 dias, observável por outros, sem prejuízo acentuado e **sem psicose**. **Tipo I**: um episódio maníaco basta. **Tipo II**: hipomania + depressão maior e **nunca** mania. Ciclotimia: 2 anos de sintomas subliminares. Exigência frequentemente esquecida: **aumento de energia/atividade** junto com o humor elevado.

Tratamento do TAB no protocolo brasileiro

Mania: estabilizador + antipsicótico; **nível 1 = lítio + risperidona**; resposta avaliada em **2 semanas**; clozapina só após duas combinações. Depressão: **monoterapia**, nível 1 lítio, depois quetiapina, lamotrigina, e associações com fluoxetina; resposta em **4 a 6 semanas**; antidepressivo isolado contraindicado. Manutenção: manter o que funcionou; **lítio é a primeira escolha**; lamotrigina previne só depressão.

Lítio

Comprimido de 300 mg; até 1.800 mg/dia; litemia-alvo **0,6–1,2 mEq/L**, colhida **12 h** após a dose e após **5–7 dias** de dose estável. Monitorização: creatinina e ureia **trimestrais**; hormônio tireoestimulante, cálcio e litemia **semestrais**. Crônico: diabetes insípido nefrogênico, hipotireoidismo, hipercalcemia, tremor fino. Único fármaco com redução de suicidalidade e mortalidade.

Intoxicação por lítio

Aguda = gastrointestinal, litemia alta, pouca neurotoxicidade. Crônica = neurológica, litemia pode ser baixa, decisão pelo exame clínico. Precipitantes: tiazídico, inibidor da enzima conversora, anti-inflamatório, desidratação, dieta hipossódica. Conduta: suspender o lítio e os precipitantes → litemia seriada a cada 2–4 h → **soro fisiológico 0,9%** → avaliar diálise. Carvão ativado não adsorve lítio. Diálise **independente da litemia** se coma, convulsão ou arritmia grave.

Transtornos de personalidade

Padrão inflexível e difuso, desde a adolescência, em ≥ 2 de 4 áreas. Grupo A estranheza, B intensidade, C medo. CID-11: gravidade obrigatória + cinco domínios de traço + padrão borderline como único qualificador categórico. Borderline: 5 de 9 critérios; instabilidade afetiva de **horas**; **psicoterapia é o tratamento** (comportamental dialética, baseada em mentalização); fármaco só para comorbidade, sedativo na crise por ≤ 1 semana.

O diferencial em uma linha

Duração, gatilho e linha de base. Blocos de dias a semanas, espontâneos, com eutimia entre eles → TAB. Picos de horas, deflagrados por evento interpessoal, sobre base disfórica crônica → borderline. E podem coexistir.

Checklist de domínio

1. Qual sintoma, além do humor elevado, é obrigatório para mania e hipomania?
2. O que diferencia mania de hipomania — e o que basta para reclassificar um tipo II em tipo I?
3. Quais pistas levantam suspeita de bipolaridade em um paciente deprimido?
4. Qual a combinação de nível 1 para mania no protocolo brasileiro e em quanto tempo se avalia a resposta?
5. Por que antidepressivo em monoterapia é contraindicado na depressão bipolar?
6. Qual a limitação específica da lamotrigina na manutenção?
7. Como e quando se colhe corretamente uma litemia?
8. Quais exames de monitorização crônica do lítio e em que periodicidade?
9. Por que um tiazídico eleva a litemia?
10. Como diferenciar tremor fino de tremor grosseiro em quem usa lítio?
11. Por que a litemia pode ser enganosa na intoxicação crônica?

12. Qual o pilar do tratamento da intoxicação e por que não se usa diurético?
13. Quais indicações de diálise independem do valor da litemia?
14. O que é a síndrome de neurotoxicidade persistente induzida por lítio?
15. Quais os critérios gerais de transtorno de personalidade?
16. Diferencie personalidade esquizoide de evitativa, e esquizotípica de paranoide.
17. Como a CID-11 passou a classificar os transtornos de personalidade?
18. Qual o tratamento de primeira linha do transtorno borderline e qual o papel do fármaco?
19. Quais três perguntas resolvem a maior parte dos casos ambíguos entre TAB e borderline?
20. O que fazer diante de um paciente que preenche critérios para ambos?

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Luana — problemas, metas e ações

Provável intoxicação por lítio com neurotoxicidade, sobre episódio maniforme em paciente com seguimento psiquiátrico irregular — pronto atendimento

Luana, 28 anos. Trazida pela família por mudança de comportamento há dias: alterna **agitação, irritabilidade e impulsividade** (gastos excessivos, conflitos) com isolamento, tristeza e vazio. **Dorme pouco sem sentir cansaço.** Relações historicamente intensas e instáveis, oscilações ao longo do dia. **Acompanhamento psiquiátrico irregular**, uso inconsistente de medicações que não sabe nomear; **suspeita de uso excessivo de comprimidos** nos últimos dias. Há 48 h: **tremores, náuseas, vômitos, fala desconexa e desorientação**. Exame: agitada, **FC 102**, PA 110×70, T 37,2 °C, **tremor grosseiro, ataxia leve**, sem déficit focal. Estado mental: parcialmente desorientada no tempo, **humor exaltado**, afeto lábil e expansivo, taquilalia, **fuga de ideias**, **grandiosidade** sem delírio estruturado, sem alucinações, distraível, **sem crítica**, agitação psicomotora.

1. Lista de problemas

#	Problema	Situação	Base
1	**Síndrome tóxica com neurotoxicidade** — estado confusional	CONFIRMADO	Tremor grosseiro, ataxia, disartria/fala desconexa, desorientação, vômitos após uso excessivo de comprimidos
2	**Intoxicação por lítio** (aguda sobre crônica)	A ESCLARECER	Quadro típico; confirma com litemia seriada e identificação das medicações
3	**Desidratação** — perpetua a retenção de lítio	CONFIRMADO	Vômitos há 48 h, FC 102; rim desidratado poupa sódio e lítio junto
4	**Episódio maniforme** com agitação psicomotora	CONFIRMADO	Humor exaltado, grandiosidade, fuga de ideias, taquilalia, menor necessidade de sono, gastos
5	**Transtorno afetivo bipolar tipo I**	A ESCLARECER	Provável pelo quadro e pelo tratamento prévio; exige história com família e prontuário, fora do estado confusional
6	**Traços de personalidade borderline**	A ESCLARECER	Relações instáveis, vazio, oscilação diária. **Não se diagnostica em crise** nem durante episódio de humor
7	**Risco de suicídio** — sobredose intencional?	A ESCLARECER	Uso excessivo de comprimidos, sintomas depressivos, impulsividade; avaliar assim que estiver orientada
8	**Co-ingestão e medicações em uso**	A ESCLARECER	Não sabe nomear; pode haver ácido valproico, benzodiazepínico ou outros
9	**Função renal, eletrólitos, tireoide e cálcio**	A ESCLARECER	Lítio agride rim, tireoide e paratireoide; definem gravidade e decisão de diálise
10	**Gestação**	A ESCLARECER	Mulher em idade fértil; muda a escolha do estabilizador (lítio e valproico)
11	**Baixa adesão e seguimento irregular**	CONFIRMADO	Causa provável tanto da recaída quanto da intoxicação
12	**Ausência de crítica** — risco de recusar tratamento	CONFIRMADO	Sem insight, agitada, pouco colaborativa
13	**Exposição financeira e conflito familiar**	CONFIRMADO	Gastos excessivos e discussões; a família é também a rede de apoio

2. Metas

Meta	Prazo	Como se verifica
Estabilizar e proteger	**Primeira hora**	Monitorizada, acesso venoso, ECG feito, lítio e fármacos retentores suspensos
Restaurar a volemia	**6–12 h**	FC normalizada, diurese ≥ 0,5 mL/kg/h, sódio estável
Levar a litemia a nível seguro	**24–72 h**	Litemia seriada em queda consistente, < 1,0 mEq/L
Reverter a neurotoxicidade	**Dias**	Orientada, sem tremor grosseiro, marcha estável
Afastar risco de suicídio e agitação perigosa	**Contínuo**	Avaliação de risco documentada; sem eventos de auto ou heteroagressão
Confirmar o diagnóstico de base	**Após desintoxicar**	História com família e prontuário; humor reavaliado sem confusão mental
Controlar o episódio maníaco	**2 semanas**	Resposta avaliada em dose adequada antes de trocar o fármaco
Alta com esquema seguro e seguimento garantido	**Na alta**	Consulta no CAPS agendada, família orientada, medicação sob guarda
Prevenir recaída e nova intoxicação	**Longo prazo**	Adesão, litemia na faixa, sem novos episódios

LEITURA DO CASO — O QUE VEM PRIMEIRO

O que ameaça a vida hoje é a **intoxicação**, não o humor. Tremor grosseiro, ataxia e desorientação em quem usa lítio são intoxicação até prova em contrário; **tremor fino seria efeito esperado**. No padrão aguda sobre crônica, o lítio já está dentro do neurônio: **a litemia pode subestimar a gravidade**, e quem manda é o exame neurológico. E enquanto houver confusão mental, **nem mania nem borderline podem ser diagnosticados com segurança** — o estado confusional contamina o exame psíquico.

3. Ações

CURTO PRAZO *da admissão às primeiras 72 horas*

Estabilização e segurança

- Sala de emergência: via aérea, nível de consciência, **monitor cardíaco**, oximetria, glicemia capilar
- **Dois acessos venosos**; sonda vesical se não houver controle de diurese
- **Suspender o lítio e tudo que o retém**: diurético, anti-inflamatório, inibidor da enzima conversora
- Observação contínua, ambiente seguro, retirar objetos de risco
- **Internar.** Se recusar, internação involuntária (Lei 10.216/2001), com comunicação ao Ministério Público em 72 h

Exames

- **Litemia agora e a cada 2–4 h** até queda consistente — uma dosagem isolada não basta
- Sódio, potássio, **cálcio**, ureia, creatinina, gasometria, glicemia, hemograma
- **Eletrocardiograma**; TSH e T4 livre
- **β-hCG**
- Rastreio de co-ingestão: nível de ácido valproico, paracetamol, toxicológico
- Pedir à família **todas as caixas e receitas** de casa

Prescrições

- **Soro fisiológico 0,9%** em alíquotas, reavaliando a cada uma; depois manutenção guiada por diurese e sódio (atenção à hipernatremia se houver diabetes insípido nefrogênico)
- **Não** usar diurético para "forçar diurese"
- **Carvão ativado não adsorve lítio** — só se houver co-ingestão adsorvível recente
- **Ondansetrona 4–8 mg EV até 8/8 h** para os vômitos (conferir QT no ECG)
- Agitação: abordagem verbal primeiro; se necessário, **benzodiazepínico em dose baixa**. Antipsicótico com cautela enquanto houver neurotoxicidade
- **Acionar nefrologia** — hemodiálise se: intoxicação grave; rim comprometido com litemia > 4,0; **rebaixamento de consciência, convulsão ou arritmia, qualquer que seja a litemia**; ou litemia > 5,0 / confusão importante / queda lenta prevista

Família

- Explicar o que está acontecendo e por que a internação
- Colher a história longitudinal: episódios anteriores, duração, internações, familiares com TAB

MÉDIO PRAZO *até a alta hospitalar*

- Resolvida a confusão, **reavaliar o humor** e confirmar o diagnóstico de base com família e prontuário
- **Avaliação formal do risco de suicídio** e da intenção da sobredose
- Se a mania persistir: **estabilizador + antipsicótico**; avaliar resposta em **2 semanas**
- **Decidir se o lítio volta:** é o que mais reduz suicídio, mas é o mais letal em sobredose e depende de adesão. Se voltar: só com volemia e rim normais, **dose reduzida** e litemia após 5–7 dias
- Alternativa do PCDT (nível 2): **ácido valproico + olanzapina** — valproico exige β-hCG negativo e **contracepção eficaz**
- Corrigir tireoide e cálcio se alterados
- Psicoeducação: sinais de intoxicação, hidratação, evitar anti-inflamatório e diurético sem avisar o médico, **proteger o sono**
- **Medicação sob guarda da família**, em quantidades pequenas
- Alta com **consulta no CAPS em até 7 dias** e plano de crise escrito

LONGO PRAZO *após a alta*

- Seguimento regular no CAPS/psiquiatria; **manter o que funcionou** no episódio
- Se em lítio: creatinina e ureia **trimestrais**; TSH, cálcio e litemia **semestrais**
- Reavaliar a personalidade **fora de episódio**: se o padrão borderline se confirmar, **psicoterapia estruturada** (comportamental dialética ou baseada em mentalização)
- Planejamento reprodutivo, discutido junto com a escolha do estabilizador
- Rastrear álcool e outras substâncias em cada consulta
- Envolver a família: reconhecer sinais precoces de recaída (menos sono, gastos, aceleração)

PONTOS A CORRIGIR NO QUE FOI DISCUTIDO NO QUADRO

Avaliação: listou sintomas (tremor, ataxia, vômitos) em vez de nomear o problema — intoxicação por lítio provável sobre episódio maniforme. **Carvão ativado e lavagem gástrica não servem para lítio.Litemia precisa ser seriada**, não uma dosagem. Faltaram **ECG, cálcio, β-hCG e a avaliação do risco de suicídio**. Nos conceitos: **depressão exige 2 semanas**, não 4 dias; hipomania difere da mania pela gravidade (sem psicose, internação ou prejuízo acentuado), não pela energia; **personalidade não tem "episódios"** — esquizoide é desinteresse por vínculos, não desconexão da realidade; **personalidade obsessivo-compulsiva é rigidez e perfeccionismo**, não obsessões e compulsões (isso é TOC); e **ISRS não trata borderline**: o tratamento é psicoterapia, e remédio só entra por comorbidade. Diurético é um dos precipitantes da intoxicação, não o único.

Construído sobre o PCDT do Transtorno Afetivo Bipolar tipo I (Portaria SAS/MS nº 315/2016), as recomendações do grupo EXTRIP (2015) para tratamento extracorpóreo e as orientações do NICE CG78 para o transtorno borderline. Doses devem ser conferidas em bula vigente e no protocolo da unidade. Os diagnósticos de base permanecem provisórios até a resolução do estado confusional e a identificação das medicações em uso.